

TRIAGEM CLINICA

Fluxogramas de Triagem Clinica

Orientacoes para encaminhamento de pacientes
baseadas em criterios clinicos

Documento contendo quatro fluxogramas de triagem clinica para aplicativo de saude: Diabetes, Hipertensao Arterial Sistematica, Dislipidemia e Evento Cardiovascular. Cada fluxograma apresenta criterios de avaliacao, niveis de alerta e prazos de encaminhamento.

Maio 2026

Ferramenta de triagem - Nao substitui avaliacao medica

Sumário

1. Fluxograma Diabetes
2. Fluxograma Hipertensão Arterial Sistêmica
3. Fluxograma Dislipidemia
4. Fluxograma Evento Cardiovascular

AVISO IMPORTANTE: Este aplicativo é apenas uma ferramenta de triagem. Em caso de dúvida ou discordância com os alertas do aplicativo, não hesite em procurar ajuda médica antes do indicado.

1. Fluxograma Diabetes

O fluxograma de diabetes tem como objetivo orientar a triagem e o encaminhamento de pacientes com base nos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c), glicemia de jejum, glicemia aleatória (HGT) e na presença ou ausência de sintomas de descompensação. O fluxo inicia com a pergunta sobre o diagnóstico prévio de diabetes e se ramifica em duas vertentes principais: pacientes já diagnosticados e pacientes sem diagnóstico prévio.

Para pacientes diagnosticados, a HbA1c é o principal marcador de controle, com metas diferenciadas para adultos (18-59 anos) e idosos (acima de 60 anos). Para pacientes sem diagnóstico prévio, investiga-se a possibilidade de diabetes novo por meio de glicemia aleatória, glicemia de jejum e HbA1c. Adicionalmente, para todos os pacientes, são estabelecidos protocolos de urgência para hiperglicemia severa (glicemia ≥ 250 mg/dL) e hipoglicemia (glicemia < 70 mg/dL).

Fluxograma Diabetes

Triagem e encaminhamento baseado em critérios clínicos

IMPORTANTE: Este aplicativo é apenas uma ferramenta de triagem. Em caso de dúvida ou discordância com os alertas, não hesite em procurar ajuda médica antes do indicado.

Tem o diagnóstico de diabetes?

SIM

Avaliar HbA1c (Hemoglobina Glicada)

HbA1c $\geq$ 9% sem sintomas de descompensação

(poliúria, polidipsia, perda ponderal, taquipneia, náuseas/vômitos, dor abdominal, desidratação, alteração do nível de consciência, cetonúria/cetonemia positiva)

DISPARO: Encaminhar ao atendimento

Endocrinologista (ou clínico) preferencialmente em até 15 dias +
Nutricionista em até 30 dias

HbA1c $\geq$ 7% e $<$ 9%

DISPARO: Encaminhar ao atendimento

Endocrinologista (ou clínico) e Nutricionista preferencialmente em até 30 dias. Obs: Idosos podem ter metas de HbA1c $<$ 7,5% ou 8%

HbA1c $<$ 7% (pacientes 18 a 59 anos)

DISPARO: Diabetes controlado

Consulta endocrinologista/clínico a cada 3 meses, não ultrapassando 6 meses. Acompanhamento regular com nutricionista recomendado

Idosos ($>$ 60 anos): HbA1c $<$ 7,5%

DISPARO: Diabetes aparentemente controlado

Idosos mais comprometidos podem ter metas glicêmicas mais elevadas. Consulta a cada 3 meses, não ultrapassando 6 meses. Nutricionista recomendado

NÃO

Glicemia aleatória $>$ 200 + sintomas

(poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso inexplicada)

DISPARO: Possível diagnóstico de diabetes

Necessita avaliação médica (endocrinologista ou clínico geral) preferencialmente em até 15 dias

Glicemia de jejum $>$ 126 e/ou HbA1c $>$ 6,5%?

Possível diagnóstico de diabetes

Tem sintomas de descompensação?

(poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso inexplicada)

SIM

DISPARO: Avaliação médica em até 15 dias

Endocrinologista ou clínico geral

NÃO

DISPARO: Avaliação médica em até 30 dias

Endocrinologista ou clínico geral

PARA TODOS OS PACIENTES

Glicemia aleatória (HGT) ou de jejum $\geq$ 250 mg/dL

Tem algum dos seguintes sinais/sintomas?

Poliúria, polidipsia, perda de peso, taquipneia, náuseas/vômitos, dor abdominal, desidratação, alteração do nível de consciência, cetonúria/cetonemia positiva

SIM

DISPARO: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

NÃO

DISPARO: Endocrinologista + Nutricionista em até 30 dias

Glicemia $<$ 70 mg/dL (Hipoglicemia)

Inconsciente, alterações mentais intensas, convulsões ou uso excessivo de insulina?

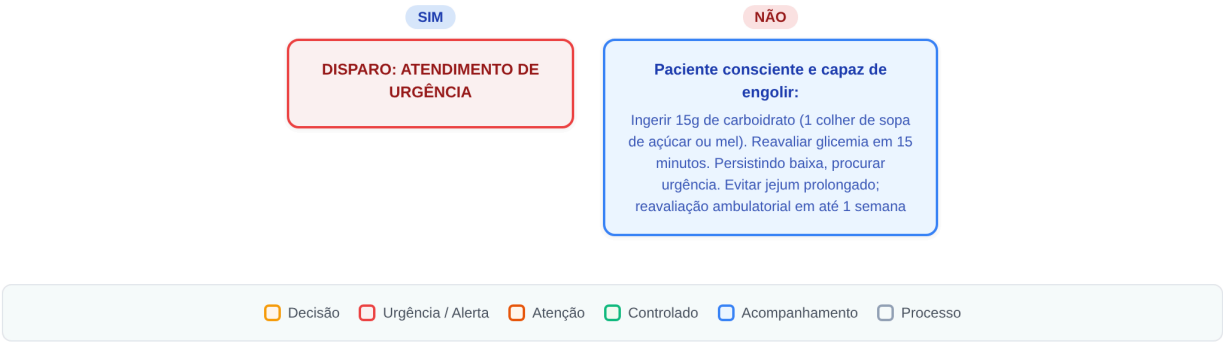


Figura 1 — Fluxograma de triagem e encaminhamento para Diabetes

2. Fluxograma Hipertensão Arterial Sistêmica

O fluxograma de hipertensão arterial sistêmica (HAS) orienta a triagem e o encaminhamento com base nos valores de pressão arterial e no uso ou não de medicação anti-hipertensiva. A estratificação é feita em duas vertentes: pacientes em uso de anti-hipertensivos (meta de PA < 130 x 80 mmHg) e pacientes sem uso de anti-hipertensivos (meta de PA < 120 x 80 mmHg).

Para pacientes em tratamento, valores acima da meta são classificados como não controlados (PA de 130x80 a 179x119 mmHg, com consulta ambulatorial em até 1 mês) ou como possível emergência (PA > 180x120 mmHg, com necessidade de avaliação médica imediata). Para pacientes sem tratamento, identifica-se a pré-hipertensão (PA de 120x80 a 139x89 mmHg) e a hipertensão confirmada (PA > 140x90 mmHg, com necessidade de confirmação em segunda medida). Adicionalmente, PA < 90x60 mmHg indica hipotensão, com possível necessidade de avaliação médica imediata, independentemente do uso de anti-hipertensivos.

Fluxograma Hipertensão Arterial Sistêmica

Triagem e encaminhamento baseado em valores de pressão arterial

IMPORTANTE: Este aplicativo é apenas uma ferramenta de triagem. Em caso de dúvida ou discordância com os alertas, não hesite em procurar ajuda médica antes do indicado.

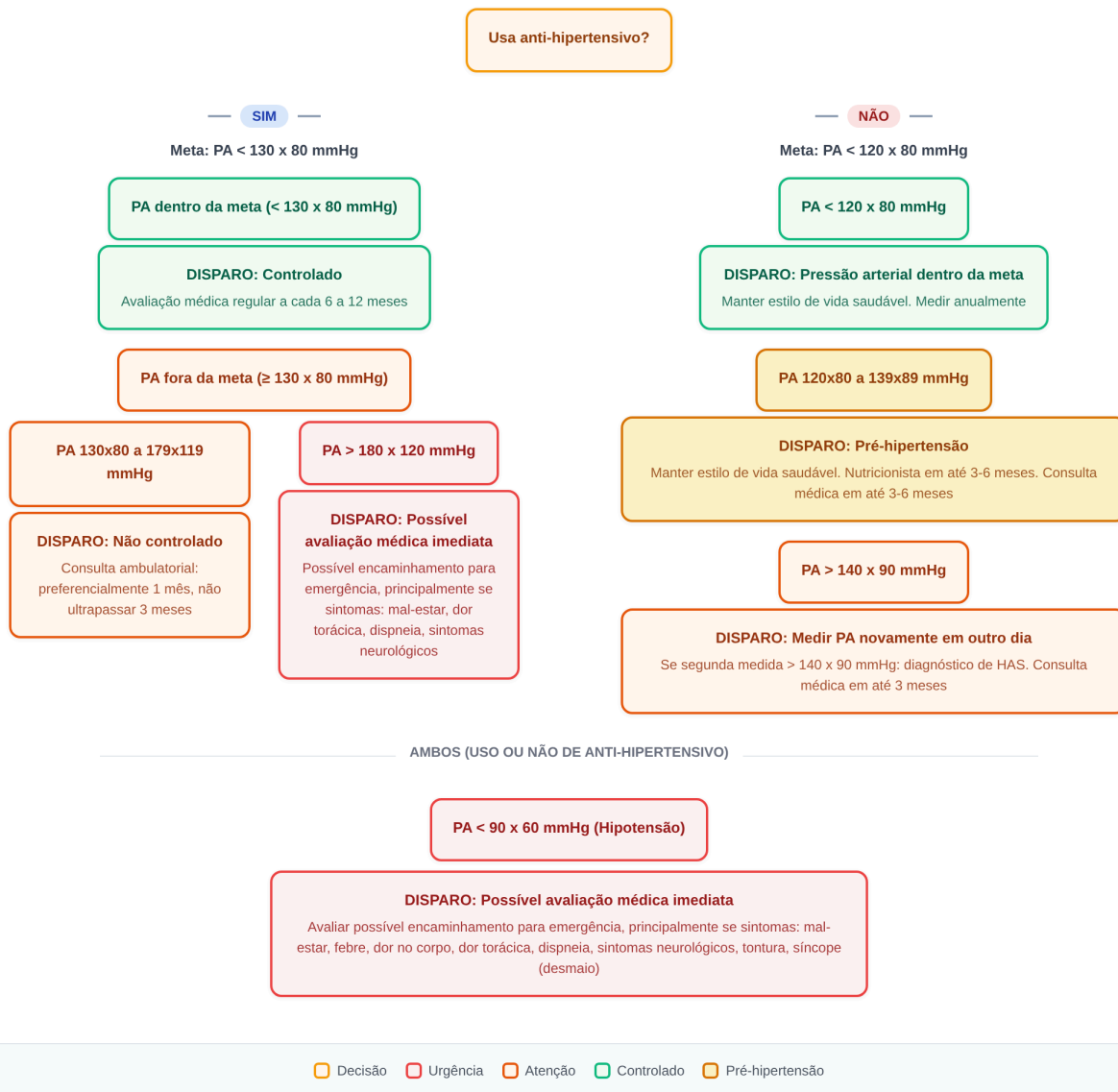


Figura 2 — Fluxograma de triagem e encaminhamento para Hipertensão Arterial Sistêmica

3. Fluxograma Dislipidemia

O fluxograma de dislipidemia orienta o encaminhamento de pacientes com base nos níveis de LDL-colesterol e triglicerídeos. Para o LDL, a estratificação é feita em quatro faixas: LDL ≥ 190 mg/dL (ou evento cardiovascular prévio sem uso de estatina, com consulta em até 1 mês), LDL entre 160 e 189 mg/dL (consulta em até 3 meses), LDL entre 100 e 159 mg/dL (avaliação individualizada em até 3 meses) e LDL < 100 mg/dL (avaliação individualizada em até 6 meses).

Para os triglicerídeos, os níveis críticos demandam atenção especial: triglicerídeos acima de 1000 mg/dL requerem consulta em até 1 semana (risco de pancreatite aguda), e triglicerídeos acima de 500 mg/dL requerem consulta em até 15 dias. Estes valores elevados representam risco iminente de complicações graves e devem ser tratados com prioridade máxima.

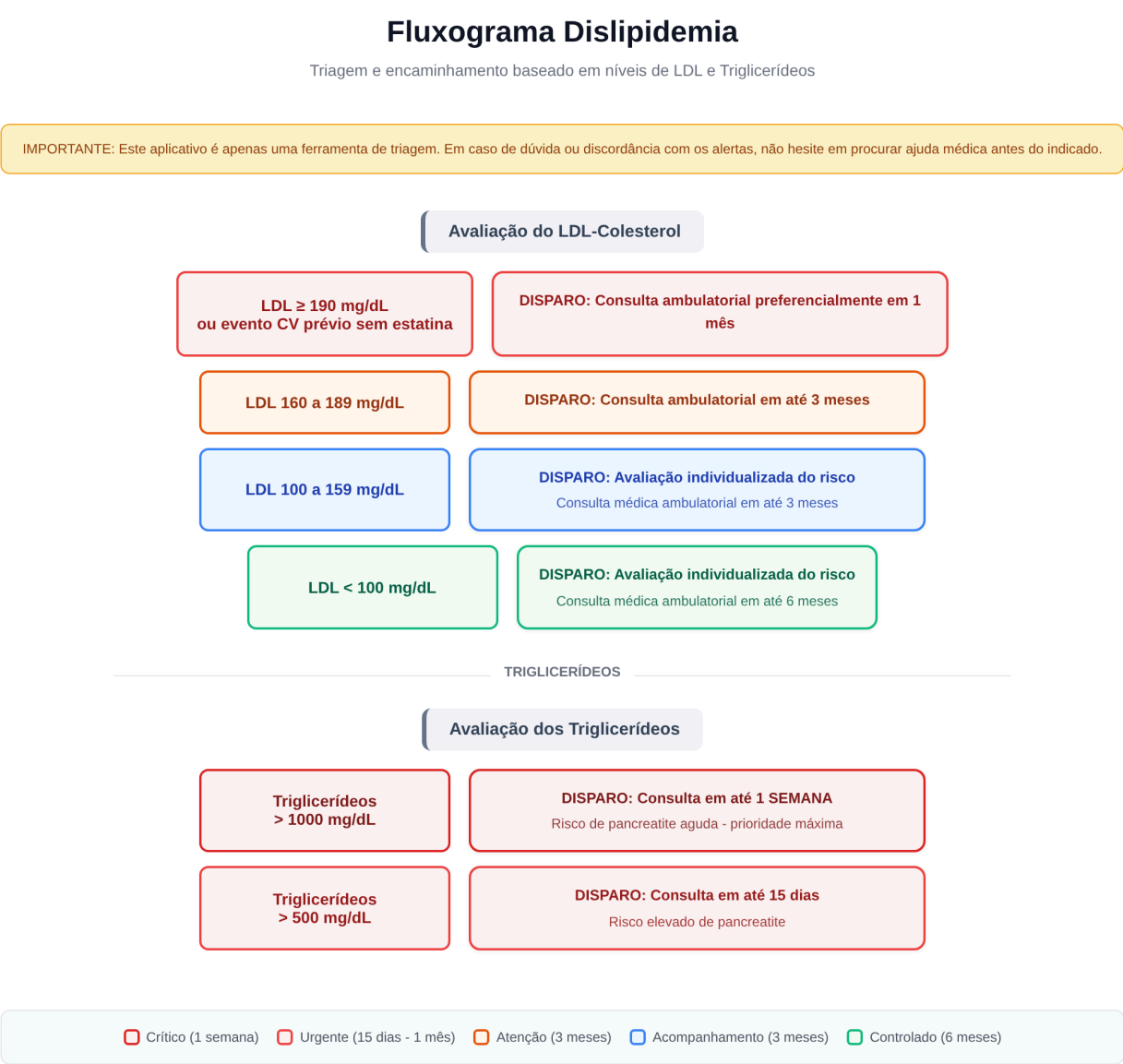


Figura 3 — Fluxograma de triagem e encaminhamento para Dislipidemia

4. Fluxograma Evento Cardiovascular

O fluxograma de evento cardiovascular tem caráter exclusivamente de urgência. Qualquer sinal ou sintoma compatível com evento cardiovascular agudo deve gerar imediato encaminhamento ao serviço de urgência/emergência. Os sinais de síndrome coronariana aguda incluem dor ou aperto no peito (com possibilidade de irradiação para braços, pescoço ou mandíbula), falta de ar, náuseas e suor frio.

Os sinais de acidente vascular cerebral (AVC) incluem déficit neurológico novo, como dificuldade para falar, diminuição de força em membros, desvio de rima labial, além de convulsões, síncope (desmaio) e perda de consciência. Diferentemente dos outros fluxogramas, neste não há estratificação por gravidade: a presença de qualquer um desses sinais indica necessidade de atendimento imediato em serviço de urgência, sem exceções.

Fluxograma Evento Cardiovascular

Identificação de sinais de evento cardiovascular agudo - Encaminhamento de urgência

IMPORTANTE: Este aplicativo é apenas uma ferramenta de triagem. Em caso de dúvida ou discordância com os alertas, não hesite em procurar ajuda médica antes do indicado.

Sinais de Evento Cardiovascular Agudo

Sintomas a serem identificados:

Dor ou aperto no peito

Irradiação para braços, pescoço ou mandíbula

Falta de ar (dispneia)

Náuseas e suor frio

Dificuldade para falar

Diminuição de força em membros

Desvio de rima labial

Convulsões

Síncope (desmaio)

Perda de consciência

Déficit neurológico agudo

DISPARO: ENCAMINHAR AO SERVIÇO DE URGÊNCIA

Qualquer um dos sintomas acima indica possível evento cardiovascular agudo (infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral) e requer avaliação médica imediata em serviço de urgência/emergência.

Síndrome Coronariana Aguda

Dor ou aperto no peito, podendo irradiar para braços, pescoço ou mandíbula. Associada a falta de ar, náuseas e suor frio.

Acidente Vascular Cerebral

Déficit neurológico novo: dificuldade para falar, diminuição de força em membros, desvio de rima labial. Convulsões, síncope, perda de consciência.

DISPARO: Urgência

Encaminhamento imediato ao serviço de urgência

DISPARO: Urgência

Encaminhamento imediato ao serviço de urgência

□ Urgência - Encaminhamento imediato □ Sinais/Sintomas

Figura 4 — Fluxograma de identificação e encaminhamento para Evento Cardiovascular